

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	子宮外孕 Ectopic Pregnancy				
編號	A31000-Q03-W-M07	制定者	R9 黃麗華	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.0 版/13 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解子宮外孕的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

子宮外孕又稱異位妊娠(Ectopic pregnancy)，是指囊胚(Blastocyst)未植入子宮腔內而在子宮腔外之部位著床。受精卵在輸卵管受精之後前進受阻或變慢，在子宮內膜之外著床即發生子宮外孕。90%的子宮外孕都發生在輸卵管，稱為輸卵管妊娠，部位包括輸卵管的壺腹部、峽部、漏斗部、繖部和間質部，而且通常發生在右側輸卵管較多，其中又以輸卵管的壺腹部最常發生。其他子宮外孕發生的部位有著床於卵巢、子宮頸、腹腔等處，但較少見。子宮外孕佔全部懷孕的 1-2%，常危及婦女的健康及日後的生育能力。

（二）症狀

子宮外孕一般較常見症狀為腹痛、陰道出血、月經過期。子宮外孕依其著床的位置及病程發展的不同，症狀表現有所差異，初期時沒有什麼特殊異常，就像一般懷孕一樣，有的婦女可能會出現懷孕徵象如：乳房壓痛、噁心感等。當受精卵繼續長大，滋養細胞破壞附近小血管，浸潤期間造成漿膜下血腫時，較敏感的女性會感覺到下腹部有輕微的脹痛、腹痛或腰酸，這是因為子宮收縮所致。由於胎盤組織發育

主題名稱	子宮外孕	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/13

較差，黃體素不足以維持子宮內膜持續發展，蛻膜性子宮內膜會呈現不規則的脫落，陰道即會有少量點狀出血的現象，有的女性會把出血誤認為是月經。未破裂之輸卵管外孕因輸卵管血腫(Hemotosalpinx)，輸卵管會呈不規則的擴張，以超音波或觸診時會發現外孕組織呈複雜性腫塊(Complex adnexal mass)，會有壓痛感。當胚胎大小超過輸卵管間隙時，即會造成輸卵管破裂而導致多量的血流入腹腔造成腹腔積血(Hemoperitoneum)，刺激腹腔及橫隔膜而引起單側尖銳性的疼痛及頸、肩膀的轉移痛，大部分的出血是緩慢的，而腹腔也逐漸變成僵硬並有壓痛。如果出血量大而流入骨盆腔，陰道檢查會引起極端的疼痛並在道格拉斯陷凹(Cul-de-sac of Douglas)可以觸摸到血塊。此時子宮內膜因胚胎未著床於其上而呈現蛻膜剝落，造成如月經般的持續出血，然後因大量出血，病人呈現休克或昏迷之現象。其他症狀還有脈搏加快、臉色蒼白、血壓下降，病人很快會陷入低血容性休克狀態。

(三) 常見檢查

1. 陷凹穿刺術(Culdocentesis)：非常有助於診斷。產婦採仰臥，兩腿分跨在檢查台的腳蹬上，針頭由陰道後穹窿插入道格拉斯陷凹。如果吸出沒有凝固的血則表示是子宮外孕，但是若沒有血液被吸出，也並不能完全排除子宮外孕的可能性。
2. 超音波檢查(Ultrasound)：在視野下可以早期確認尚未破裂的輸卵管妊娠的妊娠囊，或是在子宮腔外之部位著床妊娠的妊娠囊。
3. 腹腔鏡檢查(Laparoscopy)：可以看出是否為子宮外孕，尤其是輸卵管妊娠最易被發現，也可以藉此檢查做立即性的處理。但是若做陷凹穿刺術結果為陽性的反應，就不必再做此檢查。
4. 剖腹探查術(Laparotomy)：可用以確立診斷並做立即性的處理。
5. 診斷評估病人狀況，首先必須仔細評估病人的月經史，尤其是最後一次月經，其次必須仔細檢查骨盆腔，以確定區分任何不正常的骨盆腔腫塊和壓痛。
6. 實驗室檢查：
 - (1)血液方面：發現血紅素及血比容值下降，白血球數增加，HCG 值比正常懷孕值低。

主題名稱	子宮外孕	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/13

(2)尿液方面：懷孕測試結果為陽性。

(四) 常見治療

醫療處理的目標在於能儘早確定診斷、控制出血、除去胚胎組織和採取適當措施，以減少母體危險及對仍想懷孕的女性能保留生育能力。

1.手術治療：子宮外孕於手術後皆需追蹤血清 β -hCG，直至恢復正常為止。

(1)一般對未破裂之輸卵管妊娠，其保守療法有：

A. 輸卵管切開術(Salpingostomy)：主用於治療輸卵管壺腹部未破裂之外孕。

切開患處輸卵管、清除外孕、止血後，採自然癒合。

B. 輸卵管切開縫合術(Salpingectomy)：同輸卵管切開術，唯最後有做縫合。

但是輸卵管上的縫合痕跡可能亦會導致下一次的子宮外孕。

C. 切除病段輸卵管(Segmental resection)：主要用於處理輸卵管峽部的外孕。

D. 輸卵管繖部擠出術(Fimbrial expression)：靠近輸卵管遠端的外孕，可用

手自輸卵管繖部擠出。除非已發生輸卵管流產現象，否則擠壓對輸卵管傷害很大，不但難止血且易導致持續性外孕及再度外孕的機率。

E. 腹腔鏡(Vedio/lapascopy)：子宮外孕治療的方法多採用腹腔鏡手術，在

肚臍下緣及下腹部處開 2-4 個約 1-2 公分的小洞，打入二氧化碳，將肚子鼓脹起來，從肚臍放入內視鏡，切除子宮外孕部位，然後將子宮外孕的液體吸出。手術後腹部有 2-4 個約 1-2 公分傷口，需拆線，通常於出院後第一次回診拆線。此手術有可能會在腹部放置 1 條引流管，引流腹內血水，一般引流液量約 $<50\text{ml}/\text{天}$ 可依醫囑移除之。優點有手術後傷口小、復原較迅速、縮短住院日。以上手術後需追蹤 β -HCG 值降到正常沒懷孕的值為止，以預防有持續懷孕的情形。若 β -HCG 值沒降或反而增加，則考慮在進行一次手術治療或 Methotrexate 治療。

(2)對已破裂及出血嚴重之子宮外孕則執行輸卵管切除術，保留好的卵巢，若是子宮角外孕或合併嚴重感染者，則會考慮開腹手術完全切除子宮、輸卵管及卵巢。

主題名稱	子宮外孕	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/13

A. 開腹手術：手術後下腹部有一橫或直式的傷口約 10-15 公分。橫式傷口無需拆釘；直式傷口因外層採釘子固定，故需拆釘，一般視傷口癒合情況約手術後 5-7 天拆半釘，另一半釘通常於隔天或數天後回門診再拆。

(3)手術最主要的危險為出血，因此必須給予充分的靜脈輸液，必要時需進行輸血，以補充流失的體液。

2.MTX(Methotrexate)化學藥物治療

由於 MTX 在治療妊娠性滋養層細胞疾病有很好的成效，近年來亦有以 MTX 治療子宮外孕使胚囊萎縮的作法。因 MTX 會抑制葉酸合成，故會搭配使用 Leucovorin 以補充葉酸的流失，因此使用此藥物治療時，只要細心的照顧和配合葉酸的補充是可以預防化學藥物治療而造成的副作用。臨床上以 MTX 治療，成功的保存子宮，使孕產婦在後來又可再度懷孕生子的案例亦不少。懷孕初期，外孕組織直徑少於 4cm、輸卵管未破裂、腹腔內出血少 100cc、超音波沒有胎兒心跳及 β -HCG < 1500mIU、Progesterone < 10ng/ml 時，可以肌肉注射 MTX，或是藉由陰道超音波、腹腔鏡直接注射 MTX 入囊胚代替手術，其成功率很高注射後並不會影響日後生育功能。

(五) 護理問題

- 1.焦慮感受／與對子宮外孕病況、治療計劃及未來是否能再受孕之不確定感有關。
- 2.體液容積不足／與子宮外孕破裂大量出血有關。
- 3.疼痛不適／與疾病引起的疼痛、手術後傷口疼痛有關。
- 4.易感染／與手術後傷口、引流管留存有關。
- 5.可能性哀傷反應／與妊娠喪失有關。

(六) 護理措施

- 1.焦慮感受／與對子宮外孕病況、治療計劃及未來是否能再受孕之不確定感有關
 - (1) 評估病人焦慮程度及主要原因。
 - (2) 鼓勵及引導病人說出心中的感受和想法，以及目前不適的症狀，並給予適當的醫療處置及護理。

主題名稱	子宮外孕	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/13

- (3) 運用同理心，耐心地傾聽病人心中的感受和想法，尋找引起焦慮的原因。
- (4) 主動提供正確的疾病及治療的相關資訊給病人，適時地澄清及修正其錯誤的觀念，以減輕病人的焦慮感。
- (5) 向病人及家屬解釋有關子宮外孕的病理變化，回答有關解剖及可能之導因。
- (6) 提供未來受孕機率的說明，增加病人對未來受孕衝擊的了解及減低對後果的焦慮。
- (7) 執行醫療處置或護理照護前，應給予詳細解釋其準備工作及注意事項，並提供衛教單張閱讀，以減輕病人的不安感。
- (8) 執行醫療處置或護理照護時，應注重病人之隱私，勿過度裸露病人身體隱私部位，必要時用屏風遮擋，請異性迴避。男性醫師幫女性病人做婦科檢查時，女性護理人員應要陪同在旁。
- (9) 對需要接受手術之病人，請醫師詳細解釋手術的方法、危險性及其好處。
- (10) 向病人保證，隨時會監測她的情況使之安心。
- (11) 利用行為或認知策略，教導病人規律的呼吸、放鬆的技巧（如按摩）、冥想等，以減輕焦慮。
- (12) 轉移病人注意力，如聽音樂、聊天。
- (13) 教導病人手術後咳嗽、翻身、下床活動時，如何固定傷口，減少傷口疼痛，且會依當時疼痛程度給予控制疼痛的處置，以減輕病人害怕傷口疼痛之焦慮。
- (14) 讓病人瞭解手術後可能存在的管子及其重要性，以減少焦慮。
- (15) 介紹相同的病人，彼此經驗分享。
- (16) 多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減少焦慮。
- (17) 隨時評估病人焦慮改善狀態。
- (18) 若病人焦慮感持續無法改善，必要時依醫囑給予藥物治療，如：鎮靜、精神神經安定劑。
- (19) 必要時提供心理諮詢服務及協助參與支持團體，助其發展有效的因應技巧。

主題名稱	子宮外孕	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/13

2. 體液容積不足／與子宮外孕破裂大量出血有關

- (1) 監測病人生命徵象及輸出輸入量，必要時需監測中心靜脈壓。
- (2) 維持點滴的通暢，補充適當的體液。
- (3) 評估失血量：計算棉墊數，秤棉墊重量，以及紀錄一定時間內的出血量，並觀察顏色及味道。
- (4) 觀察有無內出血的症狀及徵象，如卡倫氏徵象、骨盆腔滿脹或壓力感等。
- (5) 評估體液缺乏的徵象如：精神狀態的改變、焦慮增加、心跳加快、頸靜脈膨脹、水腫、黏膜脫水、低血壓、暈眩及昏厥等。
- (6) 評估實驗室相關檢驗值，如 CVP、CBC、HCT 及 Hb 等。
- (7) 必要時依醫囑給予輸血。
- (8) 鼓勵病人多喝水，維持適當的營養及休息。

3. 疼痛不適／與疾病引起的疼痛、手術後傷口疼痛有關

- (1) 評估病人的疼痛部位、程度（0 不痛～10 最痛）、頻率（間歇、持續）、發作時間、持續時間及特徵（刺痛或拍動痛、深沈或表淺），並記錄疼痛的變化。
- (2) 監測生命徵象的變化，如：疼痛時，血壓上升，心跳、呼吸次數增加。
- (3) 與病人或家屬確認引發疼痛的因素，如個人的、與疾病有關的、與治療有關的。
- (4) 與病人或家屬共同討論減少或排除疼痛的方法。
- (5) 評估病人使用疼痛控制方法的意願，在病人選擇疼痛控制方法時，如止痛劑、止痛藥、自控式止痛等，應給予教導與支持。
- (6) 教導病人疼痛時採取舒適的臥位，如側臥、半坐臥、軀體彎曲位或端坐臥勢。
- (7) 鼓勵病人運用熱敷、按摩背部及休息來緩解疼痛的不適感。
- (8) 教導病人放鬆技巧或轉移注意力，如漸進式肌肉放鬆法、按摩、聽音樂、看電視、散步、閱讀、聊天，以減緩疼痛。

主題名稱	子宮外孕	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/13

(9)教導咳嗽或改變姿勢時，以手或束腹帶固定傷口。

(10)避免腹部用力，如哭鬧蹲姿、用力解便、咳嗽，預防傷口疼痛或裂開。

(11)多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減緩疼痛。

4. 易感染／與手術後傷口、引流管留存有關

(1)每班監測傷口滲出液之顏色、氣味、濃稠度及癒合情況。

(2)每班監測引流液之量、顏色、氣味、性質及周圍皮膚之完整性。

(3)監測可顯示感染的實驗室檢查，並報告異常現象。

(4)監測有關感染徵象的改變，如：體溫升高、子宮壓痛、膿樣的分泌物或惡臭的惡露。

(5)教導病人或主要照顧者炎症症狀，如紅、腫、熱、痛及徵象，如發燒、流膿，若有以上之情形應通知醫護人員。

(6)教導病人或主要照顧者引流管勿高於放置或穿刺部位，維持引流管之通暢，並教導及協助翻身或活動方式，避免壓迫引流管。

(7)教導病人或主要照顧者預防感染的方法，如接觸病人前洗手、保持傷口清潔及乾燥、避免壓迫傷口、注意衛生、營養充足等，並評估其瞭解程度。

(8)視需要更換敷料，保持傷口清潔及乾燥。

(9)若病人情況許可，與醫師討論儘早拔除侵入性治療的管路，以預防感染的發生。

(10)建議採少量多餐，以增進食量，必要時依醫囑給予維他命、營養素或適量輸液。評估病人營養狀況，給予飲食衛教。

(11)依醫囑給予抗生素或消炎的藥物。

5. 可能性哀傷反應／與妊娠喪失有關

(1)評估病人對失去胎兒原因的了解狀況，適當的提供訊息。

(2)鼓勵病人及家屬表達他們的情緒及所擔心的問題。接受病人的哀傷情緒並協助其情緒的發洩。

(3)提供心理諮詢服務及協助參與支持團體，助其發展有效的因應技巧。

主題名稱	子宮外孕	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/13

(4) 會診社會工作者提供諮詢服務，幫助其情緒的癒合。

(七) 衛教指導

1. 飲食方面

- (1) 一般而言，採腹腔鏡手術於手術後，視醫囑禁食 8 小時；開腹手術視醫囑禁食至排氣，或有腸蠕動時，依醫囑可進食。
- (2) 可以開始進食時，應先喝白開水約 30-50c.c.，若無噁心、嘔吐腹脹、腹痛、腸絞痛後，可吃白飯、新鮮自烹白稀飯、麵條等軟質飲食，勿吃太快太多，避免腸絞痛。沒有任何不適時，可以恢復正常飲食，採少量多餐，不要太油膩及太鹹。
- (3) 建議手術後病人 1 週內少攝取刺激性食物如辣椒、咖啡；少進食易產氣食物如牛奶、蛋、豆類製品、地瓜、麵包等，以防腹脹不適；增加水份攝取，以避免便秘；建議 2 週內避免進食含人參、麻油、酒等食物，避免影響傷口癒合。
- (4) 因 MTX 會抑制葉酸合成，所以 MTX 治療期間應適當補充葉酸，如深綠色的蔬菜、菠菜、胡蘿蔔、南瓜、馬鈴薯、豆類、堅果、糙米、小麥胚芽、肝臟、魚油、蛋黃等，防止白血球或血小板減少、掉頭髮、皮膚色素沉著、皮膚紅疹、口腔潰瘍、肝腎功能受損等副作用。

2. 傷口方面

- (1) 衛教腹腔鏡手術後腹部可能有 2-4 個小傷口，或是開腹手術後會有 1 個約 10-15 公分橫式或直式傷口，且必要時醫師有可能會放置傷口引流管，可能會引起身體不適。
- (2) 每班觀察傷口有無紅、腫、熱、痛，或不正常的分泌物及傷口恢復狀況。
- (3) 手術後當天不會換藥，手術後第三天會由醫師換藥，之後每 2 天換藥一次，或視當時傷口情況換藥。
- (4) 換藥步驟及方法：將無菌食鹽水滴至無菌棉棒，以傷口為中心點，由內向外塗擦清潔至傷口周圍外至少 5 公分處，再將無刺激性優點藥水滴至無菌

主題名稱	子宮外孕	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	9/13

棉棒塗擦消毒，約停留 20-30 秒，最後再使用無菌食鹽水將優點藥水擦去，消毒完畢後再以無菌紗布或無菌敷料覆蓋傷口及黏貼好。

(5) 教導病人需保持傷口及周圍皮膚清潔與乾燥。

(6) 教導腹部傷口約 10-14 天癒合，需保持清潔乾燥。

(7) 出院後建議傷口約 2-3 天換藥，或是不小心弄濕或滲濕時應更換之。

3. 傷口疼痛方面

(1) 教導在傷口換藥後或下床時使用束腹帶，減少腹部傷口牽扯，減輕傷口疼痛。

(2) 衛教 4-6 週內避免提重物，若需提 5 公斤以上重物時，建議可使用束腹帶固定傷口，以避免疼痛。

4. 活動方面

(1) 衛教手術後當天在床上應多翻身或側臥，最好每 2 小時翻身一次，促進血液循環，增加腸蠕動，以預防腸道粘連，並鼓勵病人早期下床活動。

(2) 手術後第二天盡可能採漸進式下床活動，可以先採半坐臥，若未感不適則可以採坐臥，再坐於床邊，慢慢站起走動，全程需由家屬或朋友陪伴，以防止跌倒之虞。

(3) 衛教避免長時間坐或站、勿激烈運動，如機車、騎腳踏車、開車長途旅行、爬山、游泳。

5. 衛生方面

(1) 手術後導尿管會留置大約 1 天，導尿管留置期間會給予會陰沖洗及導尿管的護理，並視情況協助移除導尿管。移除尿管後，需注意第一次解尿時間（4-6 小時內自解）及記錄排尿量與觀察尿液顏色。

(2) 手術後若陰道有血狀排泄物，應勤換產墊或棉墊，以保持乾淨，避免感染。

(3) 如廁後衛生紙應由前往後擦拭，勤換棉墊，避免感染。

(4) 病人身體清潔之照護，手術後先以擦拭方式為主，醫師會視傷口癒合狀況，評估是否可以開始沐浴。若可以沐浴時，建議宜採淋浴方式，勿盆浴及陰道

主題名稱	子宮外孕	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	10/13

灌洗，以避免傷口感染。

6. 性方面：需在醫師診察傷口癒合後，視情況約 2-6 週可恢復性生活。

7. 其他方面：

(1) 跟病人衛教術後會有肋骨及肩部酸痛不適情形，約會持續 2-3 天。

(2) 出院後若有以下情形應立即回診：傷口有紅、腫、熱、痛及滲出液情形；

體溫 $>38^{\circ}\text{C}$ 以上；解尿困難、疼痛、頻尿、有灼熱感；陰道出血量多呈鮮

紅色、惡臭。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、孫瑞瓊、林淑玲、黃樹欽、陳怡靜、徐莞雲

(2020). *產科護理學* (十版)，新文京。

(二) Stabile, G., Romano, F., Zinicola, G., Topouzova, G. A., Di Lorenzo, G., Mangino, F. P.,

& Ricci, G. (2021). Interstitial ectopic pregnancy: The role of mifepristone in the medical treatment. *International Journal of Environmental Research and PublicHealth*, 17(18), 1-9.

(三) Konar, H., Konar, L., Konar, C., Halder, A., Saha, A., & Khamaru, J. (2022).

Uncommon Ectopic Pregnancies—Challenges in the Management. *The Journal of Obstetrics and Gynecology of India*, 72, 224–234.

主題名稱	子宮外孕	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	11/13

七、附件

(略)

主題名稱	子宮外孕	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	12/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	增加及修改定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題及衛教指導之內容。	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1.醫護部改護理部。 2.改正錯別字。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	說明內容部份修辭。	102 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.2	1.第三項第(一、二、四)目部份內容刪修。 2.更新第六項文獻參考資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.3	1.第三項說明內容將參考文獻出處呈現於內文中。 2.第六項文獻參考資料更新。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	第七目之 1(2)內容修訂。	107 年 09 月 12 日 護理長會議通過
108.09.23	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日 護理長會議通過;108 年 09 月 23 日 督導會議通過公布。

主題名稱	子宮外孕	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	13/13

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.18	3.6	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.07	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.7	1. 第三項第五、六目之護理問題名稱修訂。 2. 第六項參考資料修訂。 3. 刪除內文參考文獻。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	3.8	第三項第一、二目部份內容刪修。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過； 112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.12.17	3.9	第三項第四目之 1.(1)B.說明內容修訂。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	4.0	第六項參考資料修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。